TD6 et TD7 Analyse de situation clinique

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

UE A1 TD6 et TD7 Corrigé

Domaine A-Sciences infirmières et raisonnement clinique

UE A1 S1: Fondements des sciences infirmières et raisonnement clinique

TD6-7 – Situation clinique n°1

Temps 3 Vocabulaire inconnu

Protection juridique

Définition : Le patient bénéficie d'une mesure de protection juridique, parce qu'il est considéré comme ayant besoin d'aide ou d'être représenté pour certains actes de la vie civile

AVP

Définition : Accident de la voie publique.

Fixateurs externes (FE)

Définition : Dispositifs fixés à l'extérieur du corps et reliés à l'os par des fiches, permettant de maintenir une fracture.

Antalgique palier I

Définition : Médicament utilisé pour traiter une douleur légère à modérée, ici le paracétamol.

Antalgique palier II

Définition : Antalgique destiné à des douleurs plus importantes, ici le tramadol.

VVP

Définition : Voie veineuse périphérique permettant notamment l'administration de traitements et/ou de solutés.

SUAD

Définition : Sonde urinaire à demeure.

Risque thromboembolique

Définition : Risque de formation d'un caillot pouvant entraîner notamment une thrombose ou une embolie.

CRP

Définition : Protéine C-réactive, marqueur biologique permettant notamment de rechercher une réaction inflammatoire.

Écouvillonnage

Définition : Prélèvement réalisé avec un écouvillon, notamment au niveau d'une plaie, afin de rechercher des micro-organismes.

Macrogol

Définition : Médicament laxatif utilisé pour traiter la constipation.

Microlax / microlavement

Définition : Traitement administré par voie rectale pour favoriser l'évacuation des selles.

Relation d'aide

Définition : Accompagnement du patient permettant de favoriser l'expression de ses difficultés, ressentis et besoins.

Laparotomie

Définition : Intervention ouvrant l’abdomen

Données pour comprendre la situation clinique lors de sa PES

Situation médicale

• le patient du cas, 29 ans.

• Hospitalisé en chirurgie orthopédique depuis le 03/10/2026.

• Entré aux urgences après un AVP.

• Présente des fractures bilatérales des tibias.

• Prise en charge chirurgicale en urgence avec pose de fixateurs externes aux deux jambes.

• Il est actuellement en alitement strict.

État cutané / risque infectieux

• Présence de lésions cutanées au niveau des orifices des fiches des fixateurs externes des deux jambes.

• Orifices des fiches rouges.

• Plaie décrite comme inflammatoire.

• Température à 37,9 °C.

• Nettoyage des fixateurs selon protocole.

• CRP prescrite.

• Écouvillonnage prévu.

Douleur

• Douleur localisée aux deux tibias.

• EN à 4/10.

• Douleur continue, présente le jour et la nuit et lors des mobilisations.

• Antalgique de palier II administré.

• Après traitement : EN descendue à 1/10.

Élimination

• Antécédent de constipation chronique.

• Pas de selles depuis 4 jours.

• Selles habituellement dures.

• Ventre ballonné et dur.

• Micro-lavement réalisé mais sans résultat.

• Régime enrichi en fibres et laxatifs prescrits.

Autonomie / hygiène

• Alitement strict.

• Aide nécessaire pour les soins d'hygiène.

• Aide à la toilette au lit.

• Prévention d'escarres.

• Mobilisation/changement de position réalisés.

Vécu psychologique

• Patient inquiet concernant son devenir professionnel.

• Il est danseur professionnel de street dance.

• Il souhaite pouvoir redanser.

• Il verbalise un sentiment d'inutilité: « ne plus servir à rien ».

• Il détourne la tête et ne regarde pas ses jambes.

• Il est peu communicatif.

• Une relation d'aide et une écoute active sont mises en place.

Environnement

• Vit en couple avec sa compagne.

• Sa compagne est très présente.

• Plus de lien avec ses parents depuis ses 18 ans

• Appartement au 4e étage sans ascenseur.

• Profession : danseur professionnel.

• Personne de confiance : sa compagne.

Besoins de Virginia Henderson

Respirer

Données retrouvées : FR (nombre de respirations du patient par minute), SpO surveillée ; pas de difficulté respiratoire signalée

État du besoin : Exploré / non perturbé

Boire et manger

Données retrouvées : Régime pauvre en fibres et riche en protéines ; hydratation ≈ 1,5 L/j ; régime enrichi en fibres mis en place

État du besoin : Partiellement exploré

Éliminer

Données retrouvées : Constipation chronique, absence de selles depuis 4 jours, ventre ballonné et dur, laxatifs/Microlax

État du besoin : Perturbé

Se mouvoir et maintenir une bonne posture

Données retrouvées : Fractures des deux tibias, fixateurs externes, alitement strict, difficulté de mobilisation

État du besoin : Fortement perturbé

Dormir et se reposer

Données retrouvées : Pas de trouble du sommeil signalé

État du besoin : À approfondir

Se vêtir / se dévêtir

Données retrouvées : Peu ou pas d’informations

État du besoin : Non exploré

Maintenir sa température

Données retrouvées : Température surveillée : jusqu’à 37,9 °C

État du besoin : À surveiller

Être propre, soigné et protéger ses téguments

Données retrouvées : Aide à la toilette, lésions aux fiches, plaie inflammatoire, prévention d’escarres

Éviter les dangers

Données retrouvées : Risque thromboembolique, risque infectieux, douleur, alitement

État du besoin : Perturbé / risques présents

Communiquer

Données retrouvées : Patient peu communicatif, relation d’aide et écoute active

Agir selon ses croyances et ses valeurs

Données retrouvées : Aucune donnée retrouvée

S’occuper en vue de se réaliser

Données retrouvées : Danseur professionnel, inquiétude sur la reprise de son activité, sentiment d’inutilité

Se recréer

Données retrouvées : Activité professionnelle de danse, mais loisirs/hobbies non recherchés

Apprendre

Données retrouvées : Informations/éducation concernant les soins, examens et traitements tracées, mais apprentissages et compréhension du patient peu détaillés

2 Analyse des informations collectées

Identification et contexte

le patient du cas, 29 ans, hospitalisé depuis le 03/10/2026

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Permet d’identifier le patient et de situer la prise en charge dans le temps.

Besoin perturbé : Aucun besoin directement perturbé

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Vérifier l’évolution depuis l’entrée.

Fractures bilatérales des tibias à la suite d’un accident de la voie publique

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Motif principal d’hospitalisation et explique l’immobilisation, la douleur et la dépendance actuelle.

Besoin perturbé : Se mouvoir et maintenir une bonne posture

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Type précis des fractures, évolution orthopédique, consignes d’appui.

Fractures traitées par fixateurs externes des deux jambes

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Explique l'état cutané, les soins des fiches et le risque infectieux.

Besoin perturbé : Être propre, soigné et protéger ses téguments / Éviter les dangers

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Évolution des sites de fixation, résultats de l'écouvillonnage.

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Entraîne une perte d'autonomie et augmente certains risques liés à l'immobilisation.

Besoin perturbé : Se mouvoir, être propre, éliminer

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Durée prévue de l'alitement et possibilités de mobilisation.

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Montre une dépendance actuelle pour les soins de base.

Besoin perturbé : Être propre et protéger ses téguments

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Niveau d'autonomie habituel et évolution.

Douleur aux deux tibias, EN 4/10, continue, jour et nuit, notamment à la mobilisation

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Donnée importante pour évaluer l'efficacité des antalgiques et adapter la prise en charge.

Besoin perturbé : Éviter les dangers / Se mouvoir

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Réévaluer régulièrement l'EN, notamment après traitement et mobilisation.

EN diminuée à 1/10 après administration du tramadol

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Montre une efficacité du traitement antalgique.

Besoin perturbé : Éviter les dangers

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Poursuivre la surveillance de la douleur.

Orifices des fiches rouges, plaie inflammatoire, T° 37,9 °C

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Signes faisant suspecter une infection locale.

Besoin perturbé : Éviter les dangers / Être propre et protéger ses téguments

Ce que je dois encore rechercher / questionner : CRP, écouvillonnage, évolution de la température et de l'aspect local.

Surveillance et désinfection des fixateurs externes prescrites

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Nécessaire pour prévenir/surveiller une complication infectieuse.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Résultats de l'écouvillonnage et évolution de la plaie.

Élimination alimentation hydratation

Constipation chronique

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Antécédent pouvant favoriser la constipation actuelle.

Besoin perturbé : Éliminer

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Habitudes intestinales habituelles.

Absence de selles depuis 4 jours

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Situation actuelle nécessitant une surveillance et une prise en charge.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Rechercher douleurs abdominales, nausées, gaz, efficacité du traitement.

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Signe associé à la constipation.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Évolution après le Microlax et les laxatifs.

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Confirme la tendance à la constipation.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Fréquence habituelle des selles.

Régime pauvre en fibres et peu calorique

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Peut contribuer à la constipation et doit être pris en compte dans les habitudes alimentaires.

Besoin perturbé : Boire et manger / Éliminer

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Quantités réellement consommées depuis l'hospitalisation.

Consommation hydrique environ 1,5 L/jour

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Donnée importante dans le contexte de constipation.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Quantité réellement bue pendant l'hospitalisation.

Macrogol et Microlax prescrits

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Traitement de la constipation.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Résultat après administration.

Dimension psychologique

Inquiétude concernant son devenir professionnel

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Sa profession représente une part importante de son identité et de son quotidien.

Besoin perturbé : Se réaliser

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Ce qu'il envisage pour la suite de sa carrière.

Souhaite pouvoir redanser

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Montre que la récupération fonctionnelle est un enjeu majeur pour lui.

Besoin perturbé : Se réaliser/Se mouvoir

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Ce que les médecins lui ont expliqué concernant la reprise de la danse.

Dit « ne plus servir à rien »

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Témoigne d'un sentiment d'inutilité et nécessite une attention relationnelle.

Besoin perturbé : Se réaliser, communiquer

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Évaluer son moral, ses ressources et ses attentes.

Détourne la tête et ne regarde pas ses jambes

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Peut traduire une difficulté à accepter son état actuel ; donnée à surveiller sans en tirer de diagnostic.

Besoin perturbé : Communiquer / Se réaliser

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Lui demander ce qu'il ressent lorsqu'il regarde ses jambes.

Patient peu communicatif

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Rend nécessaire une relation d'aide et une écoute adaptées.

Besoin perturbé : Communiquer

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Favoriser l'expression de ses ressentis.

Environnement et devenir

Danseur professionnel de street dance

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : La mobilité des membres inférieurs est essentielle à son activité professionnelle.

Besoin perturbé : Se mouvoir, Se réaliser

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Projet professionnel selon l'évolution médicale.

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Présence d'un soutien dans l'environnement proche.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Disponibilité réelle de la compagne pour aider au retour à domicile.

Compagne très présente

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Ressource importante pour le patient.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Type d'aide qu'elle pourra apporter.

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Élément majeur pour le futur retour à domicile puisque le patient est actuellement alité et présente des fractures bilatérales.

Besoin perturbé : Se mouvoir / Éviter les dangers

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Possibilité d'aménagement ou autre solution temporaire.

Soins de suite / rééducation envisagés

Pourquoi sont-elles significatives ? Quel lien ? Quel intérêt ? : Le devenir nécessite probablement une prise en charge rééducative compte tenu des fractures et de l'immobilisation.

Ce que je dois encore rechercher / questionner : Type, durée et lieu de la rééducation.

3 Présenter la situation de le patient du cas selon le modèle MTEVD

Maladie et thérapeutique associées

M. le patient du cas, 29 ans, est hospitalisé en chirurgie orthopédique depuis le 03/10/2026 à la suite d'un accident de la voie publique ayant entraîné des fractures bilatérales des tibias. Ces fractures ont nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence avec pose de fixateurs externes aux deux jambes. Le patient est actuellement en alitement strict.

La douleur des deux tibias, évaluée à 4/10, est prise en charge par du paracétamol systématique et du tramadol si l'EN est comprise entre 4 et 7. Après administration du tramadol, l'EN diminue à 1/10. La douleur est réévaluée après traitement et lors des mobilisations.

La constipation chronique, avec absence de selles depuis 4 jours, selles habituellement dures et ventre ballonné et dur, est prise en charge par Macrogol et Microlax, ainsi que par un régime enrichi en fibres. Le micro-lavement réalisé est resté sans résultat.

Le risque thromboembolique lié à l'immobilisation est pris en charge par de l'énoxaparine, anticoagulant prescrit à 6000 UI par voie sous-cutanée le soir.

Les orifices des fiches rouges, la plaie inflammatoire et la température à 37,9 °C font suspecter une complication infectieuse locale. La prise en charge comprend la surveillance et la désinfection des fixateurs externes selon le protocole, une CRP prescrite et un écouvillonnage prévu.

Autres prescriptions et surveillances : perfusion de G5 % de 1 L/24 h, surveillance de la sonde urinaire à demeure et de la diurèse. Le motif précis de ces prescriptions n'est pas précisé dans le document.

le patient du cas vit en concubinage à Toulon avec sa compagne, également danseuse, qui est très présente. Il vit dans un appartement situé au 4e étage sans ascenseur. Il bénéficie d'une couverture sociale et d'une mutuelle. Sa personne de confiance est sa compagne.

Son environnement est également marqué par son activité professionnelle de street dancer professionnel, qu'il exerce avec une compagnie et qui représente un élément important de son quotidien et de son identité professionnelle.

Vécu

le patient du cas exprime une inquiétude importante concernant son devenir et notamment la possibilité de reprendre son activité professionnelle de danseur. Il souhaite pouvoir redanser et verbalise un sentiment d'inutilité en disant « ne plus servir à rien ». Il évite de regarder ses jambes et se montre peu communicatif lors des soins. Une relation d'aide et une écoute active sont mises en place.

Sur le plan physique, il présente une douleur à 4/10 ainsi qu'une constipation avec absence de selles depuis 4 jours.

Devenir

Le devenir de le patient du cas est orienté vers des soins de suite et une rééducation, compte tenu des fractures bilatérales des tibias, de l'alitement strict et de son activité professionnelle de danseur. La reprise de la danse constitue une préoccupation majeure pour le patient.

Le retour à domicile devra également prendre en compte son appartement au 4e étage sans ascenseur, son niveau d'autonomie et les possibilités d'aide de son entourage.

Liens à retenir

Situation pédagogique

Le cas concerne un adulte après accident de la voie publique, avec fractures bilatérales des tibias, fixateurs externes et alitement strict. Croiser le dossier médical, le dossier infirmier et l'entretien ; distinguer les éléments actuels des antécédents et des prescriptions.

Douleur

Le corrigé rapporte une EN à 4 sur 10 puis à 1 après traitement. Cela décrit une évolution favorable au moment évalué. Réévaluer au repos et à la mobilisation, rechercher le retentissement et surveiller la tolérance du traitement.

Peau et infection

Rougeur aux orifices des fiches et température élevée sont des indices à surveiller et à transmettre. Ils ne confirment pas seuls une infection. Examiner l'évolution locale, les signes associés et les résultats des examens prescrits ; appliquer le protocole de soin.

Constipation et immobilité

Absence de selles depuis quatre jours, selles dures et ballonnement imposent de préciser transit, gaz, douleurs, nausées, apports et effet des traitements. Mettre en lien immobilité, habitudes alimentaires et médicaments. Ne pas appliquer une réponse alimentaire ou laxative automatique devant des signes de complication.

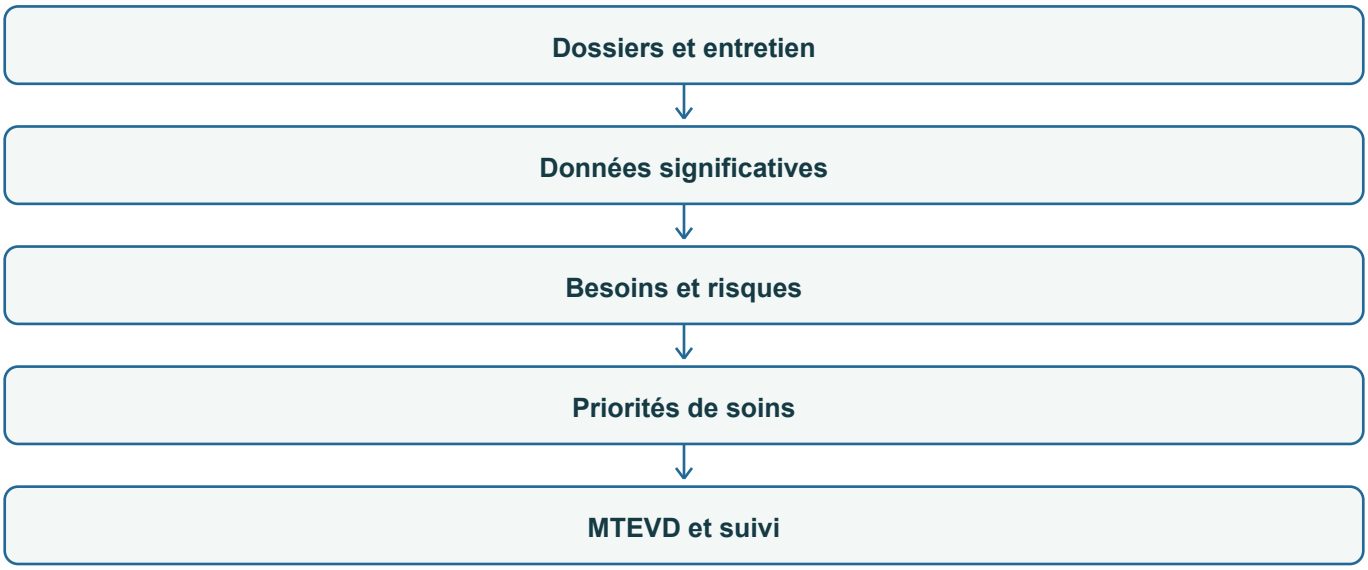
Vécu et devenir

L'inquiétude concernant la reprise professionnelle et le sentiment d'inutilité appellent une écoute et une exploration des attentes. Le logement au quatrième étage sans ascenseur est un obstacle potentiel au retour. Rechercher les aides, les possibilités de rééducation et les souhaits de la personne.

Synthèse et priorités

Organiser MTEVD, expliciter les besoins perturbés et les risques, proposer des objectifs observables puis surveiller la réponse. Les médicaments et doses du dossier sont propres au scénario pédagogique ; ils ne constituent pas un protocole à transposer à un autre patient.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Rougeur et température prouvent-elles une infection ? Non : c’est une hypothèse à explorer.

Que montre la baisse de l’EN ? Une efficacité évaluée à un moment donné.

Pourquoi intégrer le logement ? Pour apprécier la faisabilité du devenir.

Sources et portée

UE A1 TD6-7 CORRECTION FINALE.docx

Ressource Moodle correspondante